混合型 AIHA が血算に影響を与えた 1 例

◎佐野 沙耶香[1)]、高木 美希男[1)]、金瀬 彩佳[1)]、嶋田 孝紀[1)]
富山赤十字病院[1)]

【はじめに】自己免疫性溶血性貧血(AIHA)は赤血球膜上の抗原に対する自己抗体が産生され、赤血球が破壊されることで貧血をきたす疾患である。AIHA は抗体の至適温度から温式 AIHA と冷式 AIHA に分類される。今回我々は室温での赤血球凝集が自動血球計数装置による血算の測定に影響を及ぼした混合型 AIHA の 1 例を経験したので報告する。
【症例】30 代女性。前日に他院を受診し発熱、黄疸、貧血、ビリルビンと LDH の上昇を認め、溶血性貧血が疑われていた。当院血液内科に紹介受診予定であったが、症状増悪、体動困難となり当院に救急搬送された。
【検査所見】来院時血液検査の WBC：15.0×10^9/L、Hb：5.0g/dL、PLT：345×10^9/L、Ret：15.98％、LDH：736U/L、TB：3.6mg/dL。血算の初検で MCHC：49.9％、赤血球凝集を認めたため加温・5 倍希釈を実施したところ MCHC は 40.7％であった。そこで、血算の検体を遠心し、血漿を希釈液で置換したところ MCHC が 34.9％となった。血液像所見では有核赤血球が 25 個/100WBC、赤血球凝集、球状赤血球、多染性赤血球を認めた。直接クームス試験は抗 IgG 強陽性、抗補体弱陽性。寒冷凝集反応は 32 倍であった。
【経過】混合型 AIHA 疑いで入院し、翌日からステロイドで治療を開始。20 日後の採血で Hb：8.9g/dL と軽快し、退院となった。その後は外来受診でフォローされている。
【考察】AIHA は自己抗体の出現を共通とする疾患だが、症状の強さや抗体の性状は様々である。今回の症例は抗補体弱陽性であったが赤血球凝集が見られ、自動血球計数装置における RBC、Hb、MCV の測定への影響が加温や 5 倍希釈だけでは取り除けなかった。AIHA ではビリルビンの上昇による色調変化や幼弱鉄芽球の増加、赤血球凝集など多くの要因が測定値に影響を与える可能性がある。それらの影響があると考えられた場合には血漿を希釈液で置換することが有効な対応の 1 つとして挙げられるのではないかと思われた。

連絡先：076-433-2463